

Fecha Última Actualización: 21-05-2023 13:49:40

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Juan Antonio Huenchumilla Valenzuela **Rut** : 7.698.442-5 **N° Archivo** : 2125236
Edad : 65a 2m 5d **Fecha Nacto**: 16/03/1958 **Sexo** : Masculino
Dirección : Pje Las Riendas N 10866 V El Rodeo **Comuna** : La Florida **Teléfono** : 985636036

N° Epicrisis
353433

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Ingreso** : 13/05/2023 15:51 **Días Estadía** : 8
Unidad de Egreso : Unidad Intermedio Coronaria **Fecha Egreso** : 21/05/2023 13:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

CRM electiva

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso Unidad Coronaria

Nombre: Juan Huenchumilla Valenzuela

Edad: 65 años

Rut: 7.698.442-5

FIHSR: 13/05/23

FIUCO: 15/05/23

Antecedentes Medicos:

- Cardiopatía coronaria enfermedad 3 vasos pendiente resolución quirúrgica

- HTA

Antecedentes Alergicos:

- Ninguno

Antecedentes Qx

- Ninguno

Medicamentos: Losartan 50 mg c/12h, Aspirina 100 mg/día, Clopidogrel 75 mg/día, Atorvastatina 80 mg/noche.

Hábitos: tabaquismo (+) 1 cig ocasional, OH (+), Drogas (+ cocaína, suspendida hace un año)

Inmunización: covid x 4

Social: Vive con esposa, La Florida.

Ingreso de forma electiva para CRM.

Se rescata informacion de ficha medica de PULSO

Estudios realizados por angina.

CNG:

Enfermedad severa de 3 vasos sin TCI

Ecott:

Sin valvulopatía

FEVI normal

Fecha Epicrisis : 21/05/2023 13:49

Página 1 de 3

Tx de Torax:
Aorta pinzable

15.05.2023: Se realiza CRM (LIMA + 2PACS)
CEC 88 CLAMP66 REPERFUSION 15
fevi 65%
Sin incidentes intraoperatorios

Buena evolución, se extuba precozmente

Clínicamente asintomático, sin dolor torácico, sin disnea, ambiental, drenajes retirados, diuresis preservada, sin arritmias, afebril.

Mucosas normo coloreadas

yugulares -

MP+, SRA

RR, 2T, SS

Abdomen-, RHA normales

Rx. de tórax post retiro de drenajes: sin congestión, sin neumotórax. leve derrame pleural a izquierda

Angiotac de tórax:

Examen sin evidencias de tromboembolismo pulmonar.

Leve derrame pleural bilateral mayor a izquierda.

se decide el egreso

Ateromatosis aortocoronaria.

Diagnóstico de Egreso

Cardiopatía Coronaria - Enfermedad de 3 vasos

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente estable HDM, con buena evolución

Plan Post Alta

- Reposo relativo
- Prevención secundaria
- Control con cirugía cardíaca dentro de 10 días (Solicitar hora en pasillo 8 del CDT con secretaria Claudia Mena)

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos : Paracetamol 500mg 1 Comprimido Cada 6 Horas Vo
Omeprazol 20mg 1 Comprimido Cada 24 Horas Vo
Metamizol Sódico 300mg 1 Comprimido Cada 8 Horas Vo
Losartan 50mg Cmp 1 Comprimido Cada 12 Horas Vo
Colchicina 0,5mg 1 Comprimido Cada 12 Horas Vo
Carvedilol 6.25 Mg 1/2 Comprimido Cad 12 Horas Vo
Bromuro Ipratropio 0,020 Mcgr Inhalador 2 Puff Cada 6 Horas
Atorvastatina 20mg 2 Comprimidos Cad 24 Horas Vo
Amlidipino 10 Mg 1/2 Comprimido Cad 24 Horas Vo
Acido Acetilsalicílico 100mg 1 Comprimido Cada 24 Horas Vo

Controles

Fecha Epicrisis : 21/05/2023 13:49

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 21-05-2023 13:49:40

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Casimiro Montero Hernandez
Médico Tratante (Staff)